CARTE 01 - QUESTION

Une lésion visible est-elle indispensable pour reconnaître une douleur ?

CARTE 02 - QUESTION

Quelle différence existe entre nociception et douleur ?

CARTE 03 - QUESTION

Quels repères décrivent la composante sensorielle de la douleur ?

CARTE 04 - QUESTION

Que recherche-t-on dans la composante cognitive de la douleur ?

CARTE 05 - QUESTION

Un sourire exclut-il une douleur intense ?

CARTE 06 - QUESTION

Quel est le repère de durée d'une douleur chronique ?

CARTE 02 - RÉPONSE

La nociception est un processus nerveux ; la douleur est une expérience personnelle sensorielle et émotionnelle.

Cette distinction évite de réduire le vécu à une lésion ou à une réponse réflexe.

CARTE 01 - RÉPONSE

Non. La douleur est une expérience personnelle sensorielle et émotionnelle qui peut exister sans lésion visible.

Écouter le récit et rechercher les éléments cliniques sans invalider la plainte.

CARTE 04 - RÉPONSE

Les attentes, souvenirs, croyances et interprétations de la personne.

Les explorer aide à comprendre le vécu, sans en déduire une douleur imaginaire.

CARTE 03 - RÉPONSE

Localisation, intensité, durée et qualité de la douleur.

Les émotions et les représentations complètent cette description sans s'y réduire.

CARTE 06 - RÉPONSE

Une persistance ou des récidives au-delà de trois mois.

La chronicité ne précise ni le mécanisme ni l'absence d'une cause organique.

CARTE 05 - RÉPONSE

Non. Le comportement ne permet pas d'invalider à lui seul une douleur rapportée.

Vérifier la compréhension de l'outil et poursuivre l'évaluation clinique.

CARTE 07 - QUESTION

Quel rôle propre l'IDE conserve-t-il face à une douleur ?

CARTE 08 - QUESTION

Quelle est la définition d'une douleur neuropathique ?

CARTE 09 - QUESTION

Que signifie une douleur de mécanisme mixte ?

CARTE 10 - QUESTION

Qu'appelle-t-on douleur induite par un soin ?

CARTE 11 - QUESTION

Que désigne la transduction nociceptive ?

CARTE 12 - QUESTION

À quels niveaux la modulation nociceptive peut-elle agir ?

CARTE 08 - RÉPONSE

Une douleur causée par une lésion ou une maladie du système somatosensoriel.

Brûlures et décharges orientent l'évaluation mais ne suffisent pas seules au diagnostic.

CARTE 07 - RÉPONSE

Évaluer, installer, prévenir, surveiller, réévaluer, tracer et transmettre, avec un accompagnement adapté.

L'attente d'une décision thérapeutique ne supprime pas ces responsabilités.

CARTE 10 - RÉPONSE

Une douleur liée au soin ou au traitement, souvent prévisible et à prévenir.

L'anticipation ne se limite pas à un médicament systématique.

CARTE 09 - RÉPONSE

Plusieurs mécanismes douloureux coexistent chez la même personne.

Durée, intensité et mécanisme sont des axes distincts de description.

CARTE 12 - RÉPONSE

Aux niveaux périphérique, médullaire et descendant.

La modulation peut inhiber ou faciliter le traitement du message.

CARTE 11 - RÉPONSE

La transformation d'un stimulus nocif en signal électrique.

Elle se distingue de la transmission du signal et de sa perception.

Imprimer à taille réelle, recto verso bord long. Découper les cadres.

CARTE 13 - QUESTION

Quelle différence de conduction distingue Aδ et C ?

CARTE 14 - QUESTION

Quel est le principe du gate control ?

CARTE 15 - QUESTION

Que produit une sensibilisation nociceptive ?

CARTE 16 - QUESTION

Comment différencier allodynie et hyperalgésie ?

CARTE 17 - QUESTION

Un réflexe de retrait mesure-t-il la douleur consciente ?

CARTE 18 - QUESTION

Qu'est-ce qu'une douleur projetée ?

CARTE 14 - RÉPONSE

Une activité tactile peut activer des circuits médullaires inhibiteurs et réduire la transmission nociceptive.

L'effet n'est ni constant ni une preuve de disparition de la cause.

CARTE 13 - RÉPONSE

Les fibres Aδ myélinisées conduisent plus vite que les fibres C non myélinisées.

La douleur peut ainsi comporter une sensation initiale puis une sensation plus diffuse.

CARTE 16 - RÉPONSE

Allodynie : stimulus normalement indolore devenu douloureux. Hyperalgésie : réponse accrue à un stimulus normalement douloureux.

Décrire le stimulus aide à utiliser le bon terme.

CARTE 15 - RÉPONSE

Une réponse accrue et/ou un seuil d'activation diminué.

Elle peut impliquer des mécanismes périphériques et centraux.

CARTE 18 - RÉPONSE

Une douleur ressentie à distance de sa source, notamment du fait d'une convergence d'afférences.

Une localisation seule ne permet pas d'identifier avec certitude la cause.

CARTE 17 - RÉPONSE

Non. Il démontre une réponse nerveuse protectrice, pas l'intensité vécue.

L'absence de mouvement n'exclut pas non plus une douleur.

Imprimer à taille réelle, recto verso bord long. Découper les cadres.

CARTE 19 - QUESTION

Que signifie TILT dans l'entretien sur la douleur ?

CARTE 20 - QUESTION

Pourquoi TILT ne suffit-il pas à l'évaluation globale ?

CARTE 21 - QUESTION

Que faut-il tracer avec un score d'EN ?

CARTE 22 - QUESTION

Quelle différence distingue EN et EVA ?

CARTE 23 - QUESTION

Comment utiliser correctement une EVS ?

CARTE 24 - QUESTION

Les troubles cognitifs interdisent-ils toujours l'auto-évaluation ?

CARTE 20 - RÉPONSE

Il décrit surtout la composante sensorielle et doit être complété par vécu, retentissement, traitements et contexte.

Demander ce que la douleur empêche de faire et ce qui inquiète la personne.

CARTE 19 - RÉPONSE

Temps, Intensité, Localisation, Type.

Compléter par facteurs déclenchants, soulageants, retentissement et traitements déjà pris.

CARTE 22 - RÉPONSE

L'EN utilise un nombre choisi ; l'EVA utilise un repère sur une ligne mesurée.

Nommer l'outil réellement utilisé et préciser son unité.

CARTE 21 - RÉPONSE

La valeur sur 10, l'heure et la situation de mesure : repos, mouvement ou soin.

Le contexte rend la comparaison avant/après interprétable.

CARTE 24 - RÉPONSE

Non. Elle reste à essayer si une réponse fiable est possible avec une consigne adaptée.

Sinon, retenir une hétéro-évaluation validée correspondant à la situation.

CARTE 23 - RÉPONSE

Expliquer les qualificatifs proposés et conserver la même version au suivi.

Vérifier que la personne comprend la consigne plutôt que présumer sa capacité.

Imprimer à taille réelle, recto verso bord long. Découper les cadres.

CARTE 25 - QUESTION

Quels sont les cinq domaines d'ALGOPLUS ?

CARTE 26 - QUESTION

Quel repère d'ALGOPLUS appelle une prise en charge de la douleur ?

CARTE 27 - QUESTION

À quoi sert DOLOPLUS-2 et quel est son repère ?

CARTE 28 - QUESTION

Pourquoi observer avant et pendant un soin avec ECPA ?

CARTE 29 - QUESTION

Comment distinguer les usages de DAN et EDIN ?

CARTE 30 - QUESTION

Quels outils peuvent aider à évaluer un adulte non communicant en réanimation ?

Imprimer à taille réelle, recto verso bord long. Découper les cadres.

CARTE 26 - RÉPONSE

Un score supérieur ou égal à 2 sur 5.

Un résultat inférieur ne suffit pas à exclure une douleur suspectée cliniquement.

CARTE 25 - RÉPONSE

Visage, regard, plaintes, corps et comportement.

Utiliser les critères de la grille validée pour coter, sans inventer un score.

CARTE 28 - RÉPONSE

Pour repérer les changements de comportement associés au soin.

Utiliser la grille validée et comparer dans le contexte de la personne.

CARTE 27 - RÉPONSE

À évaluer une douleur prolongée chez la personne âgée avec troubles de communication ; repère : au moins 5/30.

La grille comporte dix items et doit être renseignée selon ses consignes.

CARTE 30 - RÉPONSE

BPS ou CPOT, selon l'état du patient et le protocole.

La sédation ne suffit pas à prouver l'absence de douleur.

CARTE 29 - RÉPONSE

DAN : douleur aiguë du nouveau-né. EDIN : douleur prolongée du nouveau-né.

Vérifier la population et les conditions d'emploi de chaque grille.

Imprimer à taille réelle, recto verso bord long. Découper les cadres.

CARTE 31 - QUESTION

Le DN4 complet repose-t-il uniquement sur l'entretien ?

CARTE 32 - QUESTION

Comment interpréter un DN4 complet supérieur ou égal à 4/10 ?

CARTE 33 - QUESTION

Quels trois axes suivre après une intervention antalgique ?

CARTE 34 - QUESTION

Le délai d'action d'un antalgique est-il son intervalle entre prises ?

CARTE 35 - QUESTION

Que tracer après une action contre la douleur ?

CARTE 36 - QUESTION

PCA et voie IV désignent-elles la même chose ?

CARTE 32 - RÉPONSE

Le dépistage est positif : une composante neuropathique est probable.

Le DN4 n'est ni une échelle d'intensité ni un diagnostic isolé.

CARTE 31 - RÉPONSE

Non. Il associe sept items d'interrogatoire et trois items d'examen.

Une version partielle ne doit pas être cotée comme le questionnaire complet sur dix.

CARTE 34 - RÉPONSE

Non. Le premier guide la réévaluation ; le second encadre l'espacement des administrations.

Ne pas redonner une dose au seul motif que l'effet attendu n'est pas encore constaté.

CARTE 33 - RÉPONSE

Intensité de la douleur, capacité fonctionnelle et tolérance.

Conserver un outil et des conditions comparables quand c'est possible.

CARTE 36 - RÉPONSE

Non. PCA est un mode d'administration ; IV est une voie anatomique.

Le mode, le produit, la concentration et la voie sont à vérifier séparément.

CARTE 35 - RÉPONSE

Évaluation, action et heure réelle, résultat, tolérance, alerte éventuelle et prochaine étape.

Pour un médicament, préciser aussi produit, dose et voie selon le dossier de soins.

CARTE 37 - QUESTION

Quelle est la biodisponibilité absolue par voie IV ?

CARTE 38 - QUESTION

Quels sont les cinq B de l'administration médicamenteuse ?

CARTE 39 - QUESTION

Pourquoi ne pas écraser une forme LP sans vérification ?

CARTE 40 - QUESTION

Le palier d'un antalgique suffit-il à choisir le traitement ?

CARTE 41 - QUESTION

Que vérifier lors d'une association d'antalgiques ?

CARTE 42 - QUESTION

Comment calculer le cumul quotidien de paracétamol ?

CARTE 38 - RÉPONSE

Bon patient, bon médicament, bonne dose, bonne voie et bon moment.

Ajouter allergies, interactions, terrain, dernières prises, surveillance et traçabilité.

CARTE 37 - RÉPONSE

100 %.

Ce repère ne permet pas d'improviser une conversion de dose entre voies.

CARTE 40 - RÉPONSE

Non. Il faut aussi considérer mécanisme, terrain, fonction et indication.

L'échelle historique OMS ne constitue pas un algorithme universel fondé sur un score.

CARTE 39 - RÉPONSE

Parce que cela peut altérer la libération du médicament et sa sécurité.

Consulter les règles de la spécialité, y compris pour ouverture de gélule ou administration par sonde.

CARTE 42 - RÉPONSE

Additionner le paracétamol de toutes les spécialités et de toutes les prises concernées.

Inclure les associations avec opioïdes ; vérifier aussi les horaires et le terrain.

CARTE 41 - RÉPONSE

L'indication, les substances communes, les interactions et le cumul des effets indésirables.

Une association ne se justifie pas par le seul numéro de palier.

CARTE 43 - QUESTION

Pourquoi 4 g/j de paracétamol n'est-il pas un automatisme ?

CARTE 44 - QUESTION

Quel est l'antidote du paracétamol et quelle est la priorité en cas de surdosage suspecté ?

CARTE 45 - QUESTION

Quels grands risques surveiller avec les AINS ?

CARTE 46 - QUESTION

Pourquoi ne pas interrompre seul une aspirine antiagrégante ?

CARTE 47 - QUESTION

Pourquoi distinguer néfopam injectable et néfopam oral ?

CARTE 48 - QUESTION

Quels effets du néfopam sont particulièrement utiles à repérer chez la personne âgée ?

CARTE 44 - RÉPONSE

N-acétylcystéine ; alerte médicale urgente et avis toxicologique selon l'organisation.

Ne pas attendre l'apparition de symptômes hépatiques.

CARTE 43 - RÉPONSE

Le plafond dépend du produit, du cadre prescrit, du poids et des facteurs de risque.

Petit poids, dénutrition, déshydratation et atteintes rénale ou hépatique imposent des vérifications.

CARTE 46 - RÉPONSE

Parce que la décision dépend des risques de saignement et de thrombose et doit être coordonnée médicalement.

Vérifier indication, intervention prévue et consignes avant toute modification.

CARTE 45 - RÉPONSE

Risques rénal, digestif et hémorragique, selon le terrain et les associations.

Vérifier le produit, l'hydratation, les antécédents et les autres traitements.

CARTE 48 - RÉPONSE

Confusion, vertiges, tachycardie et rétention urinaire, notamment.

Son caractère non opioïde ne le rend pas automatiquement adapté au sujet âgé.

CARTE 47 - RÉPONSE

Ce sont des présentations avec des voies et règles d'utilisation propres.

Ne pas avaler une ampoule ni convertir les doses par analogie avec un comprimé.

CARTE 49 - QUESTION

Pourquoi vérifier les associations avec le tramadol ?

CARTE 50 - QUESTION

Pourquoi la réponse à la codéine peut-elle varier ?

CARTE 51 - QUESTION

Comment distinguer morphine, naloxone et Narcan ?

CARTE 52 - QUESTION

Pourquoi la SpO_2 seule ne suffit-elle pas sous opioïde ?

CARTE 53 - QUESTION

Que faire devant somnolence excessive et bradypnée sous opioïde ?

CARTE 54 - QUESTION

Qui doit appuyer sur le bouton d'une PCA standard ?

CARTE 50 - RÉPONSE

Sa transformation partielle en morphine dépend notamment de l'activité de CYP2D6.

Une inefficacité ou une toxicité inhabituelle impose une évaluation et une transmission.

CARTE 49 - RÉPONSE

Pour rechercher notamment les interactions sérotoninergiques et le cumul de dépression du système nerveux central.

Surveiller aussi vigilance, respiration, efficacité et tolérance.

CARTE 52 - RÉPONSE

Elle ne renseigne pas à elle seule toute la ventilation ni la profondeur de sédation.

Observer aussi respiration, vigilance, réveillabilité et contexte clinique.

CARTE 51 - RÉPONSE

Morphine : agoniste opioïde. Naloxone : antagoniste opioïde. Narcan : spécialité de naloxone.

Cette distinction corrige la confusion entre activation et blocage des récepteurs.

CARTE 54 - RÉPONSE

Le patient lui-même, après information et vérification de sa compréhension.

Si une analgésie contrôlée par soignant est nécessaire, elle relève d'un autre cadre.

CARTE 53 - RÉPONSE

Alerte immédiate, sécurisation respiratoire et conduite du protocole de surdosage.

La surveillance reste nécessaire après naloxone en raison d'une possible réapparition des effets opioïdes.

Imprimer à taille réelle, recto verso bord long. Découper les cadres.

CARTE 55 - QUESTION

Le verrouillage d'une PCA élimine-t-il le risque respiratoire ?

CARTE 56 - QUESTION

La prescription d'un antidépresseur pour la douleur prouve-t-elle une dépression ?

CARTE 57 - QUESTION

Quels effets des gabapentinoïdes peuvent favoriser une chute ?

CARTE 58 - QUESTION

Les traitements locaux neuropathiques conviennent-ils à toute douleur chronique ?

CARTE 59 - QUESTION

Que signifie anticiper une douleur de soin ?

CARTE 60 - QUESTION

Quel est l'intérêt d'un signal de pause pendant un soin ?

CARTE 56 - RÉPONSE

Non. Certains antidépresseurs ont une indication antalgique, notamment neuropathique.

Expliquer l'objectif réel du traitement aide à éviter les malentendus et favorise l'adhésion.

CARTE 55 - RÉPONSE

Non. Il limite les bolus trop rapprochés mais ne supprime pas tous les risques.

Surveiller le patient, la programmation, le circuit et les doses réellement délivrées.

CARTE 58 - RÉPONSE

Non. Ils répondent à des indications précises, notamment certaines douleurs périphériques localisées.

Le caractère chronique ne suffit pas à choisir un médicament neuropathique.

CARTE 57 - RÉPONSE

Somnolence et vertiges, notamment.

La fonction rénale et les associations doivent aussi être vérifiées.

CARTE 60 - RÉPONSE

Permettre au patient de garder du contrôle et d'ajuster le rythme du soin.

Le signal doit être expliqué puis respecté.

CARTE 59 - RÉPONSE

Évaluer avant le geste et préparer avec le patient une stratégie de soulagement et d'accompagnement.

Prévoir aussi installation, matériel, délai d'action si un traitement est indiqué et possibilité de pause.

CARTE 61 - QUESTION

Que signifie MEOPA ?

CARTE 62 - QUESTION

Pourquoi ne pas appliquer un topique anesthésiant sans vérifier surface et durée ?

CARTE 63 - QUESTION

Comment choisir un moyen non médicamenteux contre la douleur ?

CARTE 64 - QUESTION

Qu'appelle-t-on effet nocebo dans le contexte de la douleur ?

CARTE 65 - QUESTION

Qu'est-ce qu'un objectif fonctionnel dans la prise en charge de la douleur ?

CARTE 66 - QUESTION

Comment distinguer signe verbalisé et signe observable de douleur ?

CARTE 62 - RÉPONSE

Parce que dose absorbée et sécurité dépendent notamment de ces paramètres.

Consulter les règles du produit, du site, de l'âge et de l'acte prévu.

CARTE 61 - RÉPONSE

Mélange équimolaire oxygène-protoxyde d'azote : 50 % de chaque gaz.

Son utilisation exige indication, protocole, matériel adapté et surveillance du patient.

CARTE 64 - RÉPONSE

Une influence défavorable des attentes et du contexte sur le vécu ou les effets ressentis.

Informer de façon compréhensible sans dramatisation ni fausse promesse.

CARTE 63 - RÉPONSE

Retenir un moyen indiqué, compris, accepté et réalisable pour cette personne.

Évaluer son effet et sa tolérance, sans retarder les autres soins nécessaires.

CARTE 66 - RÉPONSE

Verbalisé : ce que la personne exprime.
Observable : ce que le soignant constate dans son comportement ou son état.

Les deux sources se complètent sans autoriser un score inventé.

CARTE 65 - RÉPONSE

Une activité concrète à améliorer avec la personne : marcher, tousser, dormir ou se mobiliser, par exemple.

Le bénéfice doit être observé avec sa tolérance, pas seulement avec un score.

Imprimer à taille réelle, recto verso bord long. Découper les cadres.

CARTE 67 - QUESTION

Une douleur continue a-t-elle toujours une intensité constante ?

CARTE 68 - QUESTION

Comment concilier besoin urgent d'aller aux toilettes et douleur postopératoire ?

CARTE 69 - QUESTION

Que conclure d'une EN basse au repos mais encore élevée au mouvement après traitement ?

CARTE 70 - QUESTION

Quels changements postopératoires imposent une alerte rapide ?

CARTE 71 - QUESTION

Que transmettre devant une suspicion de douleur neuropathique des pieds ?

CARTE 72 - QUESTION

Comment utiliser les propos d'un proche qui banalise une douleur âgée ?

CARTE 68 - RÉPONSE

Évaluer la sécurité du lever et rechercher avec la personne une solution adaptée, éventuellement de proximité.

L'antalgie prescrite, l'accompagnement et l'installation sont coordonnés selon le délai disponible.

CARTE 67 - RÉPONSE

Non. Elle peut rester présente tout en augmentant ou diminuant selon les moments et les mouvements.

Préciser présence de fond, fluctuations, déclencheurs et périodes éventuelles sans douleur.

CARTE 70 - RÉPONSE

Douleur brutale, croissante ou discordante, difficulté respiratoire, altération de conscience, instabilité ou saignement, notamment.

Une douleur postopératoire connue n'explique pas automatiquement une aggravation nouvelle.

CARTE 69 - RÉPONSE

Le soulagement reste incomplet pour la mobilisation.

Comparer le même mouvement, vérifier traitement et délai, rechercher une cause nouvelle et transmettre pour adaptation.

CARTE 72 - RÉPONSE

Les recueillir comme des informations complémentaires sans invalider la plainte de la personne.

Rechercher douleur, capacités, contexte et retentissement plutôt que juger la fréquence des plaintes.

CARTE 71 - RÉPONSE

Qualificatifs, territoire, ancienneté, score et contexte, retentissement, état cutané et signes sensitifs ou moteurs.

Présenter l'hypothèse comme une hypothèse et signaler rapidement toute aggravation nouvelle.

Imprimer à taille réelle, recto verso bord long. Découper les cadres.

CARTE 73 - QUESTION

Pourquoi réévaluer une gonarthrose devenue plus douloureuse après une chute ?

CARTE 74 - QUESTION

Quels éléments rechercher après une chute chez une personne douloureuse chronique ?

CARTE 75 - QUESTION

Pourquoi ne pas tester la marche à tout prix après une chute douloureuse ?

CARTE 76 - QUESTION

Que recouvre le retentissement d'une douleur chronique ?

CARTE 77 - QUESTION

Quelle différence entre composantes et retentissement de la douleur ?

CARTE 78 - QUESTION

Comment construire un objectif de soin en douleur chronique ?

CARTE 74 - RÉPONSE

Circonstances, autres zones atteintes, état général, signes locaux et traitements à risque.

Comparer avec l'état habituel tout en recherchant une complication aiguë.

CARTE 73 - RÉPONSE

Parce qu'une lésion aiguë peut se surajouter à la douleur chronique.

Ne pas attribuer automatiquement l'aggravation à l'arthrose déjà connue.

CARTE 76 - RÉPONSE

Ses conséquences physiques, psychologiques, sociales et fonctionnelles.

Le score d'intensité ne décrit ni toutes les pertes d'activité ni les ressources disponibles.

CARTE 75 - RÉPONSE

Un traumatisme non évalué peut rendre la mobilisation forcée dangereuse.

Incapacité d'appui, déformation ou douleur importante demandent protection et avis adapté.

CARTE 78 - RÉPONSE

Avec la personne : activité importante, cible observable, aides nécessaires et date de réévaluation.

Par exemple une courte sortie accompagnée, adaptée au point de départ et à la tolérance.

CARTE 77 - RÉPONSE

Les composantes décrivent l'expérience ; le retentissement décrit ses conséquences sur la vie.

Une évaluation globale relie ces deux angles plutôt que les confondre.

CARTE 79 - QUESTION

Que signifie un changement aigu de comportement chez une personne âgée peu communicante ?

CARTE 80 - QUESTION

Comment évaluer une douleur quand la personne refuse un soin et communique peu ?

CARTE 81 - QUESTION

Pourquoi ne pas inventer un score à partir d'une vignette clinique ?

CARTE 82 - QUESTION

Comment préserver la participation d'une personne ayant un trouble cognitif pendant un soin ?

CARTE 83 - QUESTION

Pourquoi connaître la DCI avant d'évaluer le risque d'un palier I ?

CARTE 84 - QUESTION

Quels éléments de fragilité vérifier avant un antalgique chez la personne âgée ?

CARTE 80 - RÉPONSE

Essayer une approche simple et calme, puis une grille validée si l'auto-évaluation n'est pas fiable.

Respecter le refus, rechercher ses causes et adapter les observations et le soin.

CARTE 79 - RÉPONSE

C'est un signal clinique à évaluer : douleur et autres causes peuvent être associées.

Comparer à l'état habituel et transmettre rapidement les faits observés.

CARTE 82 - RÉPONSE

Expliquer simplement, procéder par étapes, respecter rythme et préférences et proposer des pauses.

Un environnement calme et les aides sensorielles peuvent faciliter la compréhension.

CARTE 81 - RÉPONSE

Parce que la cotation exige les observations prévues par les items de la grille.

Les données narratives orientent l'évaluation sans fournir forcément tous les critères.

CARTE 84 - RÉPONSE

Poids, nutrition, hydratation, fonctions rénale et hépatique, traitements associés et état de vigilance.

La prescription doit être rapprochée du terrain actuel, pas seulement de l'âge.

CARTE 83 - RÉPONSE

Parce que le palier ne précise ni la molécule ni ses contre-indications et effets indésirables.

Paracétamol, AINS et néfopam n'ont pas les mêmes risques.

Imprimer à taille réelle, recto verso bord long. Découper les cadres.

CARTE 85 - QUESTION

Que faire devant une somnolence inhabituelle avant un antalgique ?

CARTE 86 - QUESTION

Pourquoi adapter la surveillance à la molécule et pas seulement au palier ?

CARTE 87 - QUESTION

Que signifie une approche multimodale de la douleur ?

CARTE 88 - QUESTION

Qu'appelle-t-on déconditionnement dans le contexte d'une douleur chronique ?

CARTE 89 - QUESTION

Quatre points essentiels à vérifier avant un relais de traitement antalgique ?

CARTE 90 - QUESTION

Une suspicion d'effet indésirable doit-elle attendre une preuve certaine avant transmission ?

CARTE 86 - RÉPONSE

Les effets indésirables et précautions diffèrent entre médicaments d'un même palier.

Identifier le produit, puis cibler la surveillance sans oublier l'état général.

CARTE 85 - RÉPONSE

Évaluer éveil et respiration, sécuriser la personne et clarifier la situation avant une prise incertaine.

Une baisse de conscience ou une difficulté respiratoire impose une alerte immédiate.

CARTE 88 - RÉPONSE

Une diminution des capacités physiques liée notamment à une inactivité prolongée.

L'activité adaptée et graduée se construit selon le terrain, les objectifs et la tolérance.

CARTE 87 - RÉPONSE

Associer de façon raisonnée plusieurs moyens pharmacologiques et non pharmacologiques adaptés à la personne.

Coordonner les intervenants et réévaluer le bénéfice, la fonction et la tolérance.

CARTE 90 - RÉPONSE

Non. Prendre en charge, transmettre et suivre la démarche de pharmacovigilance applicable.

La déclaration complète l'alerte clinique et le dossier ; elle ne les remplace pas.

CARTE 89 - RÉPONSE

Compréhension des prises, tolérance, signes d'alerte et suivi prévu.

Faire reformuler les informations utiles et préciser qui contacter selon l'évolution.

Imprimer à taille réelle, recto verso bord long. Découper les cadres.